

Intoxications aux psychotropes

1. Choisir la (les) bonne(s) réponse(s) concernant les neuroleptiques :
 - a) Ils bloquent les récepteurs cholinergiques
 - b) Ils bloquent les récepteurs H1 histaminiques
 - c) Ils activent les récepteurs alpha 1 adrénergiques
 - d) Ils activent les récepteurs cholinergiques muscariniques M1
 - e) Ils bloquent les récepteurs 5HT
2. Choisir la (les) bonne(s) réponse(s) concernant les neuroleptiques :
 - a) Ils ont un effet sédatif via le blocage des récepteurs H1
 - b) Ils ont un effet atropinique via le blocage des récepteurs 5HT
 - c) Ils ont un effet de stimulant d'appétit via la stimulation 5HT
 - d) Ils ont un effet sur le poids via le blocage des récepteurs H1
 - e) Ils ont un effet sur le poids via la stimulation des récepteurs 5HT
3. En cas de surdosage par les antidépresseurs, on peut voir les effets secondaires suivants:
 - a) Un état confusionnel par action cholinergique centrale
 - b) Une sécheresse buccale par action anticholinergique centrale
 - c) Une hypotension par action adrénolytique alpha
 - d) Une tachycardie et un risque de trouble de rythme
 - e) Un risque de suicide par levée d'inhibition psychomotrice
4. Comparativement aux imipraminiques, les IMAO :
 - a) Ont un effet anticholinergique
 - b) Ont un délai d'action plus long
 - c) Ont des effets cardiovasculaires minimes
 - d) Ont une action sur la prise de poids minime
 - e) Ont une action sur la régulation thermique plus prononcée
5. Les Inhibiteurs sélectifs de recapture de la Sérotonine
 - a) Ont des effets cardiovasculaires majeurs
 - b) Sont souvent associés à un effet stabilisant de membrane
 - c) Peuvent donner des mouvements anormaux en cas de surdosage
 - d) Peuvent donner une agitation intense en cas d'intoxication
 - e) Ont une action sélective sur les récepteurs adrénergiques
6. L'effet stabilisant de membrane (ESM) :
 - a) Est traduit par un allongement des complexes QRS
 - b) Est traduit par un allongement des espaces QT
 - c) Est associé au risque de trouble de conduction intraventriculaire
 - d) Est associé au risque de trouble de conduction auriculoventriculaire
 - e) Est une complication fréquente en cas d'intoxication aux ISRS
7. Concernant l'effet stabilisant de membrane (ESM), quelle(s) proposition(s) est(sont) vraie(s):
 - a) Se limite dans les formes modérées à une fibrillation auriculaire
 - b) Se traduit dans les formes sévères à des troubles de conduction auriculo-ventriculaires
 - c) Peut être en cause d'une insuffisance circulatoire cardiogénique et vasoplégique
 - d) Est du à une inhibition des canaux calciques rapides

- e) Est souvent associé à une déviation à, gauche de l'axe du coeur
- 8. Le(s) signe(s) clinique(s) faisant fortement suspecter le syndrome sérotoninergique aigu est(sont):
 - a) convulsions
 - b) myoclonies
 - c) hypersialorrhée
 - d) hypotonie
 - e) Fièvre
- 9. Le syndrome anticholinergique comprend
 - a) Des signes atropiniques
 - b) Une hypotension artérielle
 - c) Un myosis serré
 - d) Une polyurie
 - e) Une sécheresse des muqueuses
- 10. En cas d'intoxication aiguë aux benzodiazépines, le toxidrome peut comprendre:
 - a) Un coma calme
 - b) Une fièvre
 - c) Une hypertension artérielle
 - d) Une hyporéflexie
 - e) Une bradypnée
- 11. Concernant le syndrome atropinique :
 - a) Il peut être présent dans les intoxications aux sérotoninergiques
 - b) Il peut être présent dans les intoxications aux ADT
 - c) Il est l'équivalent du syndrome anticholinergique
 - d) Il comprend une tachycardie sinusale avec globe vésical
 - e) Il comprend une mydriase bilatérale avec diarrhées
- 12. La naloxone : choisir la (les) réponse(s) exacte(s)
 - a) Est commercialisé en Tunisie sous le nom « Anexate »
 - b) Est un antagoniste pur des récepteurs μ des opiacés
 - c) Est contre indiqué en cas d'intoxications à la buprénorphine
 - d) Peut-être indiqué en cas de coma toxique agité et hypotonique
 - e) Est l'antidote en cas d'intoxication aux morphiniques
- 13. Concernant le traitement antidotique des intoxications aux psychotropes : choisir la (les) réponse(s) exacte(s)
 - a) Le Narcan est un antagoniste pur des récepteurs μ des opiacés
 - b) Le Flumazenil est l'antidote spécifique des morphiniques
 - c) Le flumazenil est contre-indiqué en cas d'intoxication aux benzodiazépines
 - d) L'Anexate peut-être indiqué en cas de coma toxique calme et hypotonique
 - e) Le Narcan peut être indiqué en cas de coma toxique calme et hypotonique

Cas clinique

Femme de 25 ans est amenée par son mari au service des urgences, pour troubles de conscience depuis 3 heures. L'examen initial trouve:

- La fréquence respiratoire à 10 cycles/min.

- La pression artérielle est à 98/55 mm Hg, le pouls à 98/min,
- Un coma calme (GCS 8/15), hypotonique, hyporéflexie, sans signes de localisation, des pupilles en position intermédiaire réactive à la lumière. Des signes atropiniques
- Elle est suivie par son médecin, prend des psychotropes, que le mari ne connaît pas

14. Les psychotropes les plus probables en cause de cette intoxication sont :

- a) Les opioïdes
- b) Les benzodiazépines
- c) Les antidépresseurs tricycliques
- d) Les neuroleptiques
- e) Les sérotoninergiques

15. Chez cette patiente la conduite en urgence est de:

- a) Réaliser le lavage gastrique
- b) Prescrire le charbon activé
- c) Prescrire le Flumazénil
- d) Commencer la réhydratation
- e) Sécuriser les voies aériennes

Cas clinique

Un monsieur de 32 ans suivi en psychiatrie depuis 10 ans, consulte aux urgences pour difficulté de déglutition avec syndrome confusionnel.

A l'interrogatoire, il y a la notion d'introduction il y a dix jours d'injections intramusculaires.

Depuis 3 jours il se plaint de douleurs musculaires, une rigidité musculaire, une hypertonie, une difficulté à la marche et une fatigabilité, une fièvre élevée.

Il est confus sans signes de localisation,

Le bilan biologique a montré une CPK à 4200 UI/l, une hyperleucocytose et une insuffisance rénale.

16. Le psychotrope le plus probable est :

- a) les antidépresseurs tricycliques.
- b) Les neuroleptiques
- c) Les sels de lithium
- d) Les benzodiazépines
- e) Les sérotoninergiques

17. Chez ce patient la conduite en urgence est de:

- a) Réaliser le lavage gastrique
- b) Prescrire le charbon activé
- c) Prescrire le Flumazénil
- d) Commencer la réhydratation
- e) Sécuriser les voies aériennes

Cas clinique

Une patiente âgée de 58 ans, suivie pour un trouble bipolaire sous traitement non précisé depuis 10ans

Transportée aux urgences par sa famille pour asthénie apparue depuis une semaine, et devenue intense, avec impossibilité de se mettre debout toute seule depuis ce matin, avec notion de diarrhées aqueuses et d'une inappétence depuis 3 jours.

A l'examen, GCS 13/15, tremblements des mains, troubles de la parole.

Signes de déshydratation extracellulaire

FR 16/mn, SpO2 98% AA, PA 98/52 mmHg, FC 95 bpm

18. Ce tableau peut coïncider avec le toxidrome d'une intoxication aux

- a) Opioïdes
- b) Antidépresseurs tricycliques
- c) Neuroleptiques
- d) Sels de lithium
- e) Sérotoninergiques

19. Les autres symptômes à rechercher sont

- a) L'hypertonie pyramidale
- b) Les myoclonies
- c) Le myosis serré
- d) La fièvre
- e) L'hypersialorrhée

20. Le protocole thérapeutique en urgence comporte

- a) L'hyperhydratation
- b) L'administration de naloxone
- c) L'épuration extrarénale
- d) Le lavage gastrique
- e) L'administration d'atropine

Cas clinique

Une patiente âgée de 21 ans est admise aux urgences après 3 heures d'une ingestion volontaire d'une dose calculée toxique de Temesta®.

21. Choisir la(les) bonne(s) réponse(s) :

- a) Il s'agit d'une intoxication aux sérotoninergiques
- b) Le toxidrome prévu comporte un syndrome atropinique
- c) L'antidote indiqué est le Narcan®
- d) Le Flumazénil peut être indiqué
- e) Un effet stabilisant de membrane est possible

22. L'examen clinique objective un toxidrome concordant avec l'intoxication au Temesta®. Quels symptômes font partie de ce toxidrome:

- a) L'hypotonie généralisée
- b) La bradypnée
- c) L'hémi-parésie
- d) Les myoclonies
- e) Le myosis

23. Parmi ces mesures, la(les)quelle(s) peut(vent) être indiquée(s) en urgence:

- a) Le charbon actif
- b) Le lavage gastrique
- c) L'intubation orotrachéale
- d) Le Narcan
- e) Le Flumazénil

Intoxications au monoxyde de carbone

24. Les facteurs qui augmentent la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine sont

- a) L'acidose
- b) L'hypoglycémie
- c) La baisse de la concentration intra érythrocytaire de 2-3 DPG
- d) L'hypercapnie
- e) L'hypothermie

25. Les facteurs qui induisent un déplacement vers la gauche de la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine sont

- a) L'acidose
- b) L'hypoglycémie
- c) La baisse du 2-3 DPG
- d) L'hypercapnie
- e) L'hypothermie

26. L'effet Bohr :

- a) Agit au niveau des poumons
- b) Est le fait que l'augmentation de la PaO₂ favorise la libération de CO₂
- c) Favorise l'oxygénation des tissus actifs
- d) Est l'induction de libération d'O₂ par la baisse du pH à proximité des tissus
- e) La libération de CO₂ induite par l'augmentation de la PaO₂

27. L'effet Haldane :

- a) Agit au niveau des poumons
- b) Est le fait que l'augmentation de la PaO₂ favorise la libération de CO₂
- c) Favorise l'oxygénation des tissus actifs
- d) Est l'induction de libération d'O₂ par la baisse du pH à proximité des tissus
- e) La libération de CO₂ induite par l'augmentation de la PaO₂

28. Concernant l'hémoglobine, une ou plusieurs propositions sont vraies:

- a) La forme non oxygénée est aussi appelée 'Tense'
- b) La forme relax est plus globuleuse que la forme tense
- c) Peut aussi fixer l'H⁺, le glucose et l'ATP
- d) A une réaction hyperbolique avec les ligands ATP et 2-3DPG
- e) Sa saturation en hémoglobine se fait selon la courbe de Barcroft

29. Concernant le monoxyde de carbone, une ou plusieurs propositions sont vraies:

- a) Se fixe sur les cytochromes pour accélérer l'utilisation d'O₂ par la cellule
- b) Peut se fixer sur toutes les protéines contenant un hème
- c) Intervient au début de la chaîne respiratoire cellulaire
- d) Est capable de déplacer l'oxygène de sa combinaison avec l'hémoglobine
- e) A une affinité à l'hémoglobine plus que 200 fois celle de le CO₂

30. Parmi les propriétés du monoxyde de carbone (CO), une ou plusieurs propositions sont vraies:

- a) Il s'agit d'un gaz incolore et reconnu à son odeur spécifique
- b) Peut être détecté dans les incendies de forêts
- c) Sa densité est presque égale à celle de l'air
- d) Il est très caustique et se fixe rapidement sur l'hémoglobine
- e) Sa présence résulte d'une combustion souvent complète

31. Concernant l'intoxication aiguë au monoxyde de carbone (CO), une ou plusieurs propositions sont vraies:

- a) La présentation clinique est peu spécifique
- b) La présentation clinique est souvent collective
- c) Les signes neurologiques sont souvent tardifs
- d) Les signes électriques sont souvent rares
- e) Les troubles circulatoires sont les plus précoces

32. L'effet toxique du monoxyde de carbone (CO) dépend:

- a) De la source de combustion
- b) Du terrain de la victime
- c) Du nombre de victimes
- d) De la durée d'exposition
- e) De la quantité de CO dans l'air

33. Dans les intoxications aiguës au monoxyde de carbone (CO) :

- a) La triade classique est faite de céphalées, vertiges, diarrhées
- b) Le tableau clinique est similaire à celui de gastroentérite
- c) Les convulsions sont le signe spécifique des formes graves
- d) L'absence de céphalées peut faire éliminer le diagnostic
- e) Le diagnostic peut être retenu sans bilan toxicologique

34. Concernant les signes cardiovasculaires dans les intoxications aiguës au monoxyde de carbone (CO), une ou plusieurs propositions sont vraies:

- a) Sont présents dans près de la moitié des cas
- b) Peut être objectivés immédiatement après l'intoxication
- c) Sont souvent prolongés durant 72 heures
- d) L'état de choc est exclusivement cardiogénique, par ischémie coronaire
- e) L'insuffisance ventriculaire gauche est possible 10 jours après l'intoxication

35. Dans les intoxications aiguës au monoxyde de carbone (CO), une ou plusieurs propositions sont vraies:

- a) La couleur rouge vif des muqueuses est synonyme de détoxification
- b) La couleur rouge vif des muqueuses est due à la carboxyhémoglobine
- c) L'apparition de phlyctènes est possible sans brûlures
- d) Les vomissements sont souvent associés à des diarrhées aqueuses
- e) Les douleurs abdominales accompagnent les élévations enzymatiques

36. Dans les intoxications aiguës au monoxyde de carbone (CO) les gaz de sang artériels peuvent montrer:

- a) Une Baisse de la PaCO₂
- b) Une hypocapnie
- c) Une alcalose respiratoire
- d) Une acidose métabolique
- e) Une baisse de la SaO₂

37. Dans les intoxications aiguës au monoxyde de carbone (CO) les éléments témoignant de la gravité sont:

- a) La détresse respiratoire
- b) Le coma hypotonique
- c) L'intoxication par fumées d'incendies
- d) Les lésions traumatiques
- e) L'ischémie coronaire

Cas clinique

- Une femme de 37 ans, sans antécédents pathologiques, est transportée aux urgences par son mari pour troubles de conscience.
- A l'examen, la patiente a été somnolente, asthénique, polypneïque à 30 cycle/min, Sa O₂= 97% à l'air ambiant, tachycarde à 111 bpm, TA = 100/60 mm Hg.
- Elle n'a pas de déficit neurologique, GCS 13/15 sous oxygène, pupilles normo dilatées, température 37°C
- Selon le mari, en rentrant tard de son travail, il l'a trouvée endormie au salon, le chauffage allumé à côté, il n'a pas pu la réveiller.
- Dernier contact téléphonique avec elle il y a 6 heures. Elle est enceinte au 4^{ème} mois.

38. Quel(s) est(sont) le(s) diagnostic(s) possible(s) chez cette patiente

- a) Intoxication au monoxyde de carbone
- b) Intoxication médicamenteuse
- c) État de mal épileptique
- d) Méningoencéphalite
- e) Éclampsie

39. Le taux de HbCO a été de 21%. Le diagnostic d'intoxication au monoxyde de carbone étant retenu, quelle devrait être la conduite thérapeutique:
- a) Une oxygénothérapie hyperbare est nécessaire vu qu'elle est enceinte
 - b) Une oxygénothérapie hyperbare est nécessaire pour prévenir le syndrome intervallaire
 - c) Une oxygénothérapie hyperbare est nécessaire pour prévenir l'éclampsie
 - d) Une oxygénothérapie normobare est nécessaire pour réduire l'HbCO à moins de 25%
 - e) Une oxygénothérapie normobare est suffisante durant les premiers 24 heures
40. Chez cette patiente, l'intoxication au monoxyde de carbone peut se compliquer de :
- a) Mort fœtale in-utéro
 - b) Prématurité
 - c) Syndrome intermédiaire
 - d) Syndrome post intervallaire
 - e) Myocardite toxique
41. Concernant l'oxygénothérapie hyperbare :
- a) Elle se fait par séances de 320 minutes.
 - b) Elle est contre-indiquée en cas de pneumothorax
 - c) Elle est indiquée après 72 heures d'oxygénothérapie normobare
 - d) Elle est contre-indiquée en cas d'état de choc
 - e) Elle est réalisée dans un caisson à 3 atmosphères
42. Le syndrome post intervallaire :
- a) Apparaît en moyenne 3 jours après l'intoxication au monoxyde de carbone
 - b) Est lié à démyélinisation de la substance blanche cérébrale
 - c) Peut se manifester par une insomnie
 - d) Peut se manifester par des myoclonies
 - e) Peut se manifester par un syndrome méningé
43. Concernant le syndrome neurologique persistant, une ou plusieurs propositions sont correctes :
- a) Est du aux lésions anoxiques histotoxiques.
 - b) Les symptômes moteurs concernent les fibres myélinisées.
 - c) L'atteinte motrice au niveau des membres est souvent distale.
 - d) L'électromyogramme confirme l'atteinte neurogène.
 - e) Il se traduit par l'apparition de nouveaux symptômes